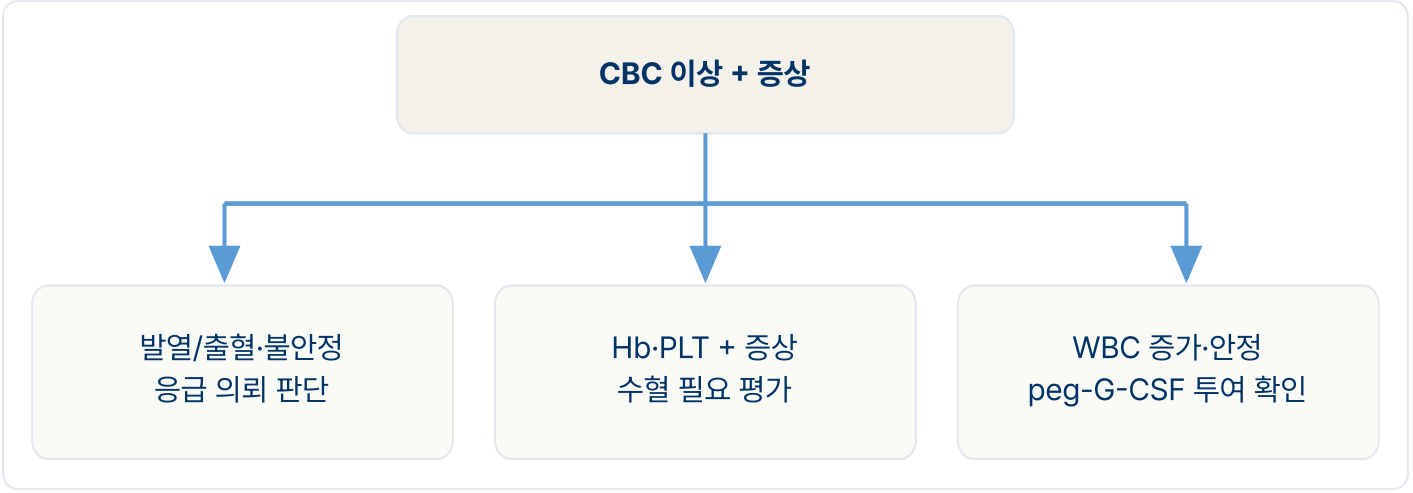
항암 중 CBC 이상 의뢰와 수혈 판단을 구분

수치 하나보다 출혈·발열·증상과 치료 시점을 먼저



혈소판 감소

강의: PLT <50,000/μL는 출혈 위험, <20,000/μL는 응급으로 즉시 의뢰합니다.
음성에서는 “5만 이하, 특히 2만 이하”로 수혈 가능한 병원 의뢰를 설명했습니다. 의뢰 기준을 곧 자동 수혈 처방으로 바꾸지 않습니다.

빈혈

강의 슬라이드: Hb <8.0 g/dL 또는 증상·빈맥·어지럼·활동저하에서 수혈 필요 판단 및 의뢰.
음성은 “8 이하”로 설명했습니다. 철결핍 등 기존 원인도 감별하고 증상과 함께
수혈을 판단합니다.

백혈구 감소 + 발열

ANC·해열제 복용·마지막 항암일을 확인합니다. ≥38.3°C 또는 ≥38.0°C ≥1시간, 특히 항암 7~14일 nadir에는 호중구감소성 발열을 고려하여 응급 의뢰합니다.

WBC 증가를 만났을 때

peg-G-CSF 뒤 예상 반응과 의뢰 신호

주사력부터 질문

발열성 호중구감소 위험 ≥20% 항암에서는 1차 예방 peg-G-CSF를 항암 다음 날 투여하는 경우가 있습니다. 뉴라스타·뉴라펙·롤론티스·듀라스틴·Lonquex 등 투여 여부를 묻습니다. 일시적인 WBC 상승·골통, 경한 ALP/LDH 상승이 나타날 수 있습니다.

임상적으로 안정하다면

주사 뒤 일시적 상승은 예상 반응입니다. 강의 증례에서 주사 3일쯤 WBC 35,000→36,000→48,000/μL로 올랐다 내려가고 nadir 후 회복했습니다. WBC 40,000/μL만으로 백혈병이라고 설명하지 말고 투약력·증상을 함께 해석합니다.

다시 의뢰를 생각할 신호

발열·오한·국소 감염징후, WBC >50,000~100,000/μL의 초고도 상승, 호흡곤란·부종·저혈압 또는 좌상복부 통증은 의뢰 신호입니다. 주사 후 증가라는 설명만으로 감염이나 합병증을 배제하지 않습니다.

골통 대증 치료

골수 증식으로 허리·골반통이 심할 수 있습니다. 투약력을 확인한 뒤 acetaminophen 또는 NSAIDs를 고려하고 강의 슬라이드는 항히스타민도 대증 선택지로 소개했습니다. 환자 상태와 동반 이상 신호를 함께 봅니다.